

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)

NO DOKUMEN	:	UDDP-MK-L2-024
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	28 Juni 2024
TANGGAL KAJI ULANG	:	28 Juni 2026
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh Shaffa Auliya Hawwa Staf Pemastian Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 21 Juni 2024
Diperiksa oleh Frida Rosita, S.Si., M.Biomed Kasubid Kontrol Dokumen UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 24 Juni 2024
Disetujui oleh Mega Octavia, S.Si Kasubid Pemastian Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia Frida	Tanda tangan:  Tanggal: 25 Juni 2024
Disahkan oleh dr. Srihartaty, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 27 Juni 2024

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)		Halaman 1 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-024 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dalam menurunkan Insiden Keselamatan pasien (Kejadian Potensial Cedera, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Tidak Cedera, dan Kejadian Tidak Diharapkan) sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, terlaksananya sistem pelaporan dan pencatatan insiden keselamatan pasien, mengetahui penyebab insiden keselamatan pasien sampai pada akar masalah dan didapatkannya pembelajaran untuk perbaikan.

2. Ruang Lingkup

SPO ini akan digunakan oleh seluruh petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam melaporkan Insiden Keselamatan Pasien di UDD Pusat PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Insiden di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
 - 3.1.1 Kondisi Potensial Cedera (KPC);
 - 3.1.2 Kejadian Nyaris Cedera (KNC);
 - 3.1.3 Kejadian Tidak Cedera (KTC); dan
 - 3.1.4 Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
- 3.2 Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan penanganan insiden sebagaimana di maksud dalam pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017
- 3.3 Dalam melakukan penanganan insiden, tim keselamatan pasien melakukan pelaporan, verifikasi, investigasi, dan analisis penyebab insiden tanpa menyalahkan, menghukum dan memperlakukan seseorang.
- 3.4 Setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan Formulir Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).
- 3.5 Pelaporan insiden ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang
- 3.6 Kejadian sentinel yang berdampak luas/nasional dilaporkan sesegera mungkin paling lama 1 (satu) jam setelah diketahuinya kejadian sentinel.



4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- 4.2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah
- 4.3 Peraturan Menteri Kesehatan No.91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.4 Perka BPOM No.10 tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIE (IKP)		Halaman 2 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-024 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Insiden keselamatan pasien adalah kejadian tidak disengaja pada saat pemberian pelayanan/*Care Management Problem (CMP)* termasuk yang disebabkan infrastruktur, sarana prasarana, *Survive Delivery Problem (SDP)* yang berpotensi atau telah menimbulkan bahaya pada pasien, pendonor, petugas dan pengunjung lain.
- 5.2 Keselamatan/*Safety* adalah bebas dari bahaya atau risiko (*hazard*)
- 5.3 *Hazard*/bahaya adalah suatu "keadaan, perubahan atau tindakan yang dapat meningkatkan risiko pada pasien
- 5.4 *Harm*/Cedera adalah dampak yang terjadi akibat gangguan struktur atau penurunan fungsi tubuh dapat berupa fisik, sosial dan psikologis
- 5.5 Kondisi Potensial Cedera (KPC) adalah suatu kondisi yang sangat berpotensi menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden atau berisiko menimbulkan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
- 5.6 Kejadian Nyaris Cedera (*near-miss* atau hampir cedera) atau KNC merupakan insiden yang belum sampai terpapar ke pasien, donor, atau petugas
- 5.7 Kejadian Tidak Cedera (KTC) adalah insiden keselamatan pasien yang sudah terpapar pada pasien, donor, atau petugas namun tidak menyebabkan cedera.
- 5.8 Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) adalah insiden keselamatan pasien yang menyebabkan cedera pada pasien, donor, atau petugas
- 5.9 Kejadian Sentinel (*Sentinel Event*) adalah suatu kejadian yang berdampak luas. Kejadian sentinel merupakan salah satu jenis insiden keselamatan pasien yang harus dilaporkan yang menyebabkan terjadinya hal-hal berikut ini:
 - 5.9.1. Kematian.
 - 5.9.2. Cedera permanen.
Cedera permanen adalah dampak yang dialami pasien atau pendonor yang bersifat *irreversible* akibat insiden yang dialami misalnya kecacatan kelumpuhan, kebutaan, tuli, dan lain-lainnya.
 - 5.9.3. Cedera berat yang bersifat sementara/*reversible*.
Cedera berat yang bersifat sementara adalah cedera yang bersifat kritis dan dapat mengancam nyawa yang berlangsung dalam suatu kurun waktu tanpa terjadi cedera permanen/gejala sisa, namun kondisi tersebut mengharuskan pemindahan pasien atau pendonor ke tingkat perawatan yang lebih tinggi/pengawasan untuk jangka waktu yang lama
- 5.10 Analisis Akar masalah/ *Root Cause Analysis (RCA)* adalah suatu proses berulang yang sistematis dimana faktor - faktor yang berkontribusi dalam suatu insiden diidentifikasi dengan merekonstruksi kronologis kejadian menggunakan pertanyaan 'mengapa' yang diulang hingga menemukan akar penyebabnya dan penjelasannya. Pertanyaan 'mengapa' harus ditanyakan hingga tim investigator mendapatkan fakta, bukan hasil spekulasi.

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)		Halaman 3 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-024 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

6. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggungjawab
Kepala UDD	Membentuk Tim Investigasi insiden keselamatan pasien
Manajer Kualitas	- Memberikan nomor kontrol dokumen - Menyimpan dokumen SPO yang asli dan membuat salinan yang akan didistribusikan kepada bagian yang terdapat dalam daftar distribusi dokumen - Mengesahkan SPO Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Memastikan audit internal terhadap SPO Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dilakukan dengan baik
Kepala Bidang Pelayanan Darah, Kepala Bidang Pembinaan dan Kepala Bidang Penunjang	Memastikan pelaksanaan SPO Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dilakukan dengan tepat sesuai prosedur dan indikasi yang telah ditetapkan
Petugas	Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien sesuai dengan prosedur dan indikasi yang telah ditetapkan
Tim Investigasi Keselamatan Pasien/ Tim Mutu	- Melakukan melakukan investigasi komprehensif atau analisis akar masalah (RCA) pada semua kejadian sentinel dalam kurun waktu tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari. - Menganalisis KTD, KNC, KTC, KPC dengan melakukan investigasi sederhana kurun waktu yaitu <i>grading</i> biru tidak melebihi 7 (tujuh) hari, <i>grading</i> hijau tidak melebihi 14 (empat belas) hari. - Menganalisis data laporan insiden keselamatan pasien, dipantau dan dilaporkan secara berjenjang setiap triwulan untuk mendeteksi pola, tren serta mungkin variasi berdasarkan frekuensi pelayanan dan atau risiko. - Melakukan tindakan korektif kejadian insiden Keselamatan Pasien setelah diketahui penyebabnya - Melakukan Tindakan korektif harus dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya agar tidak terjadi keberulangan

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

 Pelang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIE (IKP)		Halaman 4 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-024 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

7. Prosedur

7.1. Alur Pelaporan

7.1.1 Buat alur Pelaporan Insiden kepada Tim Keselamatan Pasien di UDD Pusat PMI

- 7.1.1.1. Apabila terjadi suatu insiden (KNC/KTD) di UDD Pusat PMI, wajib segera ditindaklanjuti (dicegah/ ditangani) untuk mengurangi dampak/akibat yang tidak diharapkan.
- 7.1.1.2. Setelah ditindaklanjuti, buat segera laporan insidennya dengan mengisi Formulir Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) pada akhir jam kerja
- 7.1.1.3. Isi Formulir Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), segera serahkan kepada atasan langsung pelaporan. (atasan langsung disepakati sesuai keputusan manajemen: manajer kualitas/Kepala Bidang/Kasubid/Kasie).
- 7.1.1.4. Atasan langsung akan memeriksa laporan dan melakukan *grading* risiko insiden yang dilaporkan
- 7.1.1.5. Tentukan Hasil *grading* untuk bentuk investigasi dan analisa yang akan dilakukan sebagai berikut:
 - **Grade Biru** : Investigasi sederhana oleh atasan langsung, waktu maksimal 1 minggu
 - **Grade Hijau** : Investigasi sederhana oleh atasan langsung, waktu maksimal 2 minggu
 - **Grade Kuning** : Investigasi Komperhensif/ analisis akar masalah/ RCA oleh manajer kualitas, waktu maksimal 45 hari
 - **Grade Merah** : Investigasi Komperhensif/ analisis akar masalah/ RCA oleh manajer kualitas, waktu maksimal 45 hari
- 7.1.1.6. Lakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden dilaporkan ke Tim Mutu.
- 7.1.1.7. Analisa kembali hasil investigasi dan laporan insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan (RCA) dengan melakukan regrading yang dilakukan oleh Tim Mutu UDD Pusat PMI.
- 7.1.1.8. Lakukan analisis akar masalah/ *Root Cause Analysis* (RCA) Untuk *grade* Kuning/Merah, Tim Mutu
- 7.1.1.9. Lakukan RCA, setelah itu Tim Mutu akan membuat laporan dan rekomendasi untuk perbaikan serta "pembelajaran" berupa: petunjuk/*safety alert* untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali
- 7.1.1.10. Hasil RCA, rekomendasi dan rencana kerja dilaporkan kepada Kepala UDD Pusat PMI
- 7.1.1.11. Berikan umpan balik rekomendasi untuk "perbaikan dan pembelajaran" diberikan umpan balik kepada unit kerja terkait.
- 7.1.1.12. Lakukan monitoring dan evaluasi perbaikan oleh Tim Mutu

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)		Halaman 5 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-024 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 7.1.2 Laporkan insiden ke mutu fasyankes (laporan insiden keselamatan pasien)
 Laporan hasil investigasi sederhana/ analisis akar masala/RCA yang terjadi pada pasien dan telah mendapatkan rekomendasi dan solusi oleh tim mutu/ Kepala UDD dikirimkan ke Mutu Fasyankes melalui <https://mutufasyankes.kemkes.go.id/>
- 7.2. Analisis matriks *grading* risiko
- 7.2.1 Penilaian matriks risiko adalah suatu metode analisa kualitatif untuk menentukan derajat risiko suatu insiden berdasarkan dampak dan probabilitasnya.
- 7.2.1.1. Dampak (*consequences*) penilaian dampak/akibat suatu insiden adalah seberapa berat akibat yang dialami pasien mulai dari tidak ada cedera sampai meninggal (Tabel 1)
- 7.2.1.2. Probabilitas/frekuensi/*likelihood* atau penilaian tingkat probabilitas risiko adalah seberapa seringnya insiden tersebut terjadi (Tabel 2)

Tabel 1. Penilaian Dampak Klinis/Konsekuensi/Severity

Level	Deskripsi	Dampak
1	Insignifikan	Tidak ada cedera
2	Minor	Cedera ringan, dapat diatasi dengan pertolongan pertama
3	Moderate	- Cedera sedang, berkurangnya fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual secara semipermanent/reversible/tidak berhubungan dengan penyakit - Berhubungan dengan penyakit : setiap kasus yang memperpanjang perawatan
4	Mayor	Cedera berat/luas/kehilangan fungsi utama permanent (motorik, sensorik, psikologis, intelektual), permanent/irreversible/tidak berhubungan dengan penyakit
5	Kathastropik	Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)		Halaman 6 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-024 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Tabel 2. Penilaian Probabilitas/Frekuensi

Level	Frekuensi	Aktual
1	Sangat jarang	Dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun
2	Jarang	Dapat terjadi dalam 2 - 5 tahun
3	Mungkin	Dapat terjadi 1 -2 tahun
4	Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
5	Sangat sering	Terjadi dalam minggu / bulan

7.2.2 Masukan dalam Tabel matriks *grading* Risiko untuk menghitung skor risiko dan mencari warna *bands* risiko setelah nilai dampak dan probabilitas diketahui.

7.2.2.1. Skor risiko

Skor risiko = Dampak X Probabilitas

Cara menghitung skor risiko : untuk menentukan skor risiko digunakan matriks *grading* risiko (tabel 3) :

- Tetapkan frekuensi pada kolom kiri
- Tetapkan dampak pada baris ke arah kanan
- Tetapkan warna *bands*-nya, berdasarkan pertemuan antara frekuensi dan dampak

7.2.2.2. *Bands* Risiko

Bands risiko adalah derajat risiko yang digambarkan dalam empat warna yaitu : Biru, Hijau, Kuning dan Merah. Warna *bands* akan menentukan investigasi yang akan dilakukan (tabel 3)

- *Bands* BIRU : Investigasi sederhana
- *Bands* HIJAU : Investigasi sederhana
- *Bands* KUNING : Investigasi komperhensif/RCA
- *Bands* MERAH : Investigasi komperhensif/RCA

Warna *Bands* adalah hasil pertemuan antara nilai dampak yang diurut kebawah dan nilai probabilitas yang diurut ke samping kanan

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)		Halaman 7 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-024 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Tabel 3. Matriks Grading Risiko

Matriks Analisis Risiko (P X D)			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Insignifikan	Minor	Moderate	Mayor	Katahastropik
P R O B A B I L I T A S	5	Hampir pasti terjadi	Moderate	Moderate	High	Extreme	Extreme
	4	Sering terjadi	Moderate	Moderate	High	Extreme	Extreme
	3	Mungkin terjadi	Low	Moderate	High	Extreme	Extreme
	2	Jarang terjadi	Low	Low	Moderate	High	Extreme
	1	Hampir tidak pernah terjadi	Low	Low	Moderate	High	Extreme

Tabel 4. Tindakan sesuai Tingkat dan Bands Risiko

Zona	Tindakan
Extreme	Risiko ekstrim, dilakukan RCA paling lama 45 hari, membutuhkan tindakan segera, perhatian sampai ke Kepala UDD
High	Risiko Tinggi, dilakukan RCA paling lama 45 hari kaji dengan detil & perlu tindakan segera serta membutuhkan perhatian top manajemen
Moderate	Risiko Sedang, dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Manajer Kualitas sebaiknya menilai dampak terhadap biaya dan kelola risiko
Low	Risiko rendah, dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu diselesaikan dengan prosedur rutin

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)		Halaman 8 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-024 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

8. Lampiran

Formulir Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

(UDDP-MK-L4-041)

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal berlaku	Referensi	Riwayat Perubahan
001	28 Juni 2024	- Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah	Dokumen Baru MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :